

TEMA 8.5 • NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

Accidente Vascular Encefálico (AVE)

PERFIL EUNACOM 1.10.1.009
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

ELA, Esclerosis Múltiple y Epilepsia

ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica)

- **Causa:** degenerativa (2ª motoneurona y 1ª motoneurona)
- **Clínica:**
 - - **Mezcla** de 1ª y 2ª motoneurona
 - - **Exclusivamente motora** (sin compromiso sensitivo)
 - - Progresiva e incurable (sobrevida 3–5 años)
- **Diagnóstico:** clínico (no requiere exámenes confirmatorios)
- **Tratamiento:** soporte (ventilación, alimentación)

Clínica 1ª vs. 2ª Motoneurona

TABLA 8.5.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	1ª MOTONEURONA (PIRAMIDAL)	2ª MOTONEURONA (DENERVACIÓN)
Tono muscular	Hipertonía	Hipotonía
Reflejos	Hiperreflexia + Babinski (+)	Hiporreflexia
Fasciculaciones	No	Sí
Atrofia	Leve	Marcada

ELA = hipertonía + hiperreflexia + atrofia + fasciculaciones (todo a la vez)

Esclerosis Múltiple (EM)

- **Causa:** autoinmune → desmielinización del **SNC** (cerebro, tronco, médula, cerebelo, nervio óptico)
- **Afecta sustancia blanca** (no la gris)
- **Diagnóstico:** RNM cerebral (focos de desmielinización)
- - Apoyo: punción lumbar (proteínas oligoclonales en LCR)
- **Clínica:** signos focales de instalación **gradual** (horas-días) ≠ AVE (súbito)
- **AUGE** en Chile → interferón cubierto

Tratamiento

TABLA 8.5.2: FASE VS TRATAMIENTO	
FASE	TRATAMIENTO
Crisis aguda	Corticoides EV (metilprednisolona)
Inter crisis (prevención recaídas)	Interferón beta

PERLA CLÍNICA EUNACOM

EM vs. Guillain-Barré: - EM: desmielinización del **SNC** - Guillain-Barré: desmielinización del **SNP** (sensitivo + motor + ascendente)

Epilepsia y Crisis Convulsivas

Clasificación

TABLA 8.5.3: TIPO VS SUBTIPOS		
TIPO	SUBTIPOS	CARACTERÍSTICA
Focal	Parcial simple	Sin pérdida de conciencia
	Parcial compleja	Con pérdida de conciencia
	Focal → generalizada secundaria	Empieza focal, después generaliza
Generalizada	Tónico-clónica	Fase tónica + fase clónica
	Tónica	Solo fase tónica
	Atónica	Pierde tono → cae
	Mioclónica	Saltitos involuntarios
	Ausencia	"Se le va la onda" sin caer

EUNACOM CRITERIOS

Si empieza focal → siempre se clasifica como **focal**, aunque luego generalice.

Diagnóstico

TABLA 8.5.4: TIPO VS EXAMEN		
TIPO	EXAMEN	ANTICONVULSIVANTES
Focal	RNM o TAC con contraste (buscar tumor/lesión)	Fenitoína / carbamazepina
Generalizada	Exámenes generales + EEG	Ácido valproico / lamotrigina
Tónico-clónica generalizada	EEG	Fenitoína

Diagnóstico de epilepsia

- **2 crisis estereotipadas** (iguales) sin causa explicada → epilepsia
- **1 crisis + EEG alterado** → epilepsia
- **1 sola crisis** → "primoconvulsión" → descartar causa metabólica → esperar 2ª crisis o EEG alterado

Convulsiones Febriles (Pediátrico)

- **Edad:** 5 meses – 6 años
- **Benigna:** buen estado general, sin signos meníngeos → educar + paracetamol

TABLA 8.5.5: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Benigna, primera vez	Paracetamol + educar padres
Recurrente	Paracetamol + diazepam VO/rectal (si fiebre)
Convulsionando ahora	Lorazepam 0,1 mg/kg EV (niños) / 4 mg EV (adultos)
Con signos meníngeos / aspecto tóxico	TAC → Punción lumbar → descartar meningitis
CF compleja (focal, > 15 min, ≥ 2 en 24 h)	RNM buscando lesión focal

Estatus Convulsivo

- **Definición:** convulsión ≥ 30 min sin recuperación (**no esperar 30 min para actuar**)

Tratamiento escalonado

- **Lorazepam EV** (4 mg adulto / 0,1 mg/kg niño) + **carga de fenitoína EV**
- Si falla → **Fenobarbital**
- Si falla → **Pentobarbital o propofol** (anestesia general)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 65 años presenta hemiparesia derecha de inicio súbito hace 2 horas. El TAC de cerebro sin contraste es normal. ¿Cuál es la conducta más importante?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Accidente Vascular Encefálico (AVE). Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de AVE: signos focales de inicio SÚBITO. TAC sin contraste diferencia isquémico de hemorrágico.
- AVE isquémico: trombólisis con rtPA (NO estreptoquinasa) dentro de 4.5 horas es LA medida más importante. Aspirina desde el inicio, heparina después de 48 horas.
- Neuroprotección en todo AVE: O₂, anticonvulsivantes SOS, normotermia, glicemia normal, PA <220/120 (isquémico) o <170/110 (hemorrágico).
- AVE hemorrágico: aspirina, heparina y trombólisis CONTRAINDICADAS. Cirugía solo si enclavamiento.
- Arteria cerebral media (más frecuente/grave): predominio facio-braquial. Anterior: predominio crural. Posterior: hemihipostesia + defectos visuales.
- Estudio de fuente embólica obligatorio en AVE isquémico y TIA: eco-Doppler carótidas + ecocardiograma + Holter de arritmia.
- TIA: igual que AVE pero se resuelve <24h. Manejo igual excepto trombólisis. Estudio de fuente embólica fundamental.
- Disección carotídea/vertebrobasilar: dolor cervical + cefalea en trueno + AVE + antecedente de elongación/yoga.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE))

PREGUNTA 1

Paciente de 65 años presenta hemiparesia derecha de inicio súbito hace 2 horas. El TAC de cerebro sin contraste es normal. ¿Cuál es la conducta más importante?

- A)** Iniciar heparina endovenosa de inmediato
- B)** Realizar trombólisis endovenosa con rtPA
- C)** Solicitar resonancia magnética para confirmar diagnóstico
- D)** Realizar trombólisis con estreptoquinasa
- E)** Iniciar aspirina 325 mg y observar evolución

PREGUNTA 2

Paciente de 58 años presenta súbitamente cefalea, vértigo, ataxia y disfagia. ¿Cuál es el territorio vascular más probablemente afectado?

- A)** Arteria cerebral media
- B)** Arteria cerebral anterior
- C)** Sistema vertebrobasilar
- D)** Arteria cerebral posterior
- E)** Arteria carótida interna

PREGUNTA 3

Paciente de 72 años presenta episodio de hemiparesia izquierda que se resuelve completamente en 45 minutos. ¿Cuál es el estudio MÁS importante a realizar?

- A)** Electroencefalograma
- B)** Resonancia magnética de cerebro
- C)** Estudio de fuente embólica: eco-Doppler carótidas, ecocardiograma y Holter de arritmia
- D)** Angiografía cerebral de urgencia
- E)** Punción lumbar

RESUMEN: ACCIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO (AVE)

Esta clase cubre el accidente vascular encefálico (AVE), diferenciando entre isquémico y hemorrágico. Los AVE isquémicos pueden ser embólicos (asociados a fibrilación auricular) o trombóticos, siendo los más frecuentes los lacunares (asociados a hipertensión arterial). Los AVE hemorrágicos se asocian principalmente a hipertensión arterial y angiopatía amiloidea. El diagnóstico es clínico: signos focales de inicio súbito. El TAC sin contraste diferencia isquémico de hemorrágico. El manejo del AVE isquémico incluye: 1) medidas de neuroprotección (oxígeno, anticonvulsivantes SOS, normotermia, glicemia normal, PA <220/120), 2) aspirina 325 mg desde el inicio, 3) heparina después de 48 horas, 4) trombólisis con rtPA endovenoso dentro de 4.5 horas (la medida más importante), y 5) cirugía solo si hay enclavamiento. El AVE hemorrágico se maneja igual pero sin aspirina/heparina/trombólisis, con PA <170/110. Se revisan las clínicas por territorio vascular: arteria cerebral anterior (hemiparesia de predominio crural, contralateral, con desorientación y mutismo acinético), arteria cerebral media (la más frecuente y grave, predominio facio-braquial), arteria cerebral posterior (hemihipostesia mayor que hemiparesia, predominio crural, con defectos del campo visual), y sistema vertebrobasilar (cefalea, vértigo, ataxia, de inicio súbito). Se aborda también el síndrome alterno, la disección carotídea y vertebrobasilar, y el accidente isquémico transitorio (TIA), con énfasis en el estudio de fuente embólica (eco-Doppler de carótidas, ecocardiograma, Holter de arritmia).